

SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR

Luis Felipe Sánchez-Cousido, Ana López-González, Irene Delgado-Sillero

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace referencia al Síndrome de Vena Cava Superior (SVCS) secundario a neoplasias, otras causas de dicho síndrome no serán discutidas aquí.

El SVCS deriva de la obstrucción (total o parcial) al flujo de sangre a través de la misma, dificultando el retorno venoso de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. La obstrucción puede estar causada por trombosis de la VCS o invasión o compresión externa, en algunas ocasiones ambos mecanismos coexisten.

En la época preantibiótica las complicaciones derivadas de las infecciones suponían la principal causa del SVCS. Posteriormente los procesos malignos suponen hasta el 90% de los casos. Actualmente, la incidencia del SVCS secundario a trombosis ha aumentado, principalmente por el uso de dispositivos intravasculares. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente: principalmente el carcinoma de células pequeñas (50% aproximadamente), seguido del carcinoma epidermoide (25% aproximadamente). Los linfomas representan la segunda causa con aproximadamente el 10%, la tercera causa las metástasis ganglionares mediastínicas: tumores germinales y cáncer de mama. La trombosis es la causa no maligna más frecuente de SVCS.

DIAGNÓSTICO

Los pacientes pueden presentar disnea hasta en un 54%, tos, cefalea, mareo, confusión, edema de extremidades superiores, ingurgitación yugular, inyección conjuntival, síncope y disfagia. La exploración física puede mostrar la **triada clásica**: circulación colateral, edema en esclavina (cérvico-facial, torácico y de miembros superiores) y cianosis facial. Cuando la instauración es brusca existe la posibilidad de aparición de edema cerebral con el riesgo de fallecimiento del paciente. La clínica suele aumentar cuando el paciente se inclina hacia delante o con el decúbito supino. El aumento de la cianosis, del edema facial y congestión cefálica cuando se levanta/eleva los brazos por encima de la cabeza se conoce como **El signo de Botermann**.

El diagnóstico del SVCS se basa en hallazgos clínicos (venas dilatadas del cuello y circulación colateral en la pared torácica anterior) y radiológicos, las técnicas de imagen mas usadas son:

- **La radiografía de tórax.** Hasta en el 80-90% puede revelar ensanchamiento mediastínico, masa en hemitórax derecho o masa mediastínica, menos frecuente adenopatías o derrame pleural generalmente derecho (25%).
- **La tomografía computarizada del tórax** usando contraste intravenoso es una herramienta excelente para establecer la causa de obstrucción.
- **Resonancia magnética o la venografía radionúclida.** En caso de estar contraindicada la tomografía computarizada.
- **El eco-doppler** puede ser útil si la causa es un trombo.

Etiología

<u>causas neoplásicas</u>	<u>causas no neoplásicas</u>
---------------------------	------------------------------

Cáncer de pulmón (75%)

- carcinoma de células pequeñas
- carcinoma de células no pequeñas

Linfoma no Hodgkin (10-12%)**Otros tumores metastásicos ganglionares mediastínicos (9%)**

- Neoplasia de mama
- Tumores germinales

Trombosis de la VCS

- Dispositivos intravasculares: catéteres, alambres de marcapasos, derivaciones venosas peritoneales.
- Vasculitis.
- Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Fibrosis mediastínica

- Mediastinitis fibrosa idiopática.
- Postradioterapia.
- Infecciones: tuberculosis, sífilis, actinomicosis, aspergilosis, blastomicosis, nocardiosis, histoplasmosis.
- Tiroiditis de Riedel

Neoplasias benignas

Teratoma, timoma, tumor desmoide, higroma quístico.

Otros: bocio endotorácico, aneurisma de aorta, de subclavia, sarcoidosis.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento del SVCS depende de la naturaleza de la obstrucción, por tanto, se debe diferir en lo posible el uso de terapias definitivas hasta obtener un diagnóstico histológico.

- El tratamiento sintomático consistiría en elevación del cabecero.
- **Oxigenoterapia.**
- **Corticoides** (dexametasona 4mg/6h) si existe elevación de la presión intracraneal. Disminuyen la reacción inflamatoria asociada al tumor o a la irradiación.
- **Diuréticos** ocasionalmente: furosemida 20mg. i.v. aunque existe cierta controversia por el riesgo trombótico que entraña la deshidratación.
- **Anticoagulación:** en caso de trombosis se realizara la anticoagulación. Es el tratamiento de elección si la causa del SVCS es trombótico, es más eficaz si se realiza por a través del cateter, si el trombo se asocia al catéter deberá de retirarse y se iniciara la anticoagulación.
- **Terapia endovascular (stent1):** indicado tanto en causa maligna o benigna, se realiza de forma urgente asociado a radioterapia en casos de urgencias y/o emergencia cuando el paciente presente estridor por obstrucción de vía aérea, edema laríngeo, inestabilidad hemodinámica y/o coma secundario a edema cerebral.

En beneficio de un diagnóstico más preciso debe demorarse el uso de quimioterapia o radioterapia, siendo la colocación de un stent una alternativa válida en situaciones comprometidas. Cuando el diagnóstico es conocido, en función del mismo podría intentarse quimioterapia en tumores quimiosensibles (Cáncer de pulmón de célula pequeña, tumores germinales y linfomas) o radioterapia.

BIBLIOGRAFÍA

- Kantarjian. The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e. The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2016.
- Aguilar Rodríguez F. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. [Madrid]: [Luzán 5]; 2012.
- Cruz Hernández J, Rodríguez Sánchez C, Barco Morillo E. Oncología clínica. Madrid: Aula Médica; 2012.